

INDICADO POR: Internet☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

LUIZ GUSTAVO SANTANA DA CRUZIDADE: 32 PESO: 143 ALTURA: 1,72 PROFISSÃO: Engenheiro CivilSINTOMAS: sonolência diurna, cansaço, rouco.

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: pregabalina (hernia lombar)MÉDICO: Dr. Guilherme SalomonMARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ NEXERCÍCIO FÍSICO: parou a 5 meses / Pilates 2x semanaHORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 20-20:30hHORA QUE DORME: 22h HORA QUE ACORDA: 5hCOCHILO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ NFUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 3xCIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: glabro CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:OVERLAP: não MALLAMPATI: III IAH: 824clh SPO2: 82%PATOLOGIAS ASSOCIADAS: investigando HAS / tratamento de hernia lombar.

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

17/01/25 Avaliação Locação masc. obscuro N3024/01/25 P = 10.3 med / Perc. 11.8 cmH₂O. (M) NatashaIAH = 2.8 e/evm. de uso: 4h30'Bem adaptada, porém retiro a masc. s/ver. Av. claudia18/02/25 P = 11 cmH₂O (med) fixo P = 11 cmH₂OIAH = 1.1 e/evm. de uso: 5h5'fuga: 10,1clh/m (perc)Oriento diário dosonoNatasha

RELATÓRIO DE POLISSONOGRAFIA

DADOS DO PACIENTE:

Nome: LUIZ GUSTAVO SANT ANNA DA CRUZ
ID: 0
Altura: 1,72 m
Peso: 110 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 21-10-1992
IMC: 37,18

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:06:21
Data do Exame: 17-01-2018
Médico Solicitante: DR. GUILHERME SALOMON DOMINICIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – PARÂMETROS DO SONO:

Início da Gravação:	17/01/2018 21:06	Tempo acordado antes do sono (min)	37,0
Luzes Apagadas:	17/01/2018 21:06	Acordado após o início do sono (WASO) (min)	83,5
Início do Sono:	17/01/2018 21:43	Acordado após o sono (min)	---
Luzes Acesas:	18/01/2018 05:51	Tempo total Acordado (min)	120,5
Final da Gravação:	18/01/2018 05:52	Tempo de estágio REM (min)	100,5
Tempo no Leito (min)	525,5	Tempo de estágio NREM (min)	304,5
Tempo total de Sono (min)	405,0	Tempo de ondas lentas (min)	30,0
Final do Sono:	18/01/2018 05:51		

DADOS DO ESTAGIAMENTO:

Latência para Início do Sono (min)	37,0
Latência para sono REM (min)	152,0
Latência para estágio N1 (min)	37,0
Latência para estágio N2 (min)	37,5
Latência para estágio N3 (min)	234,0

	Tempo (min)	Valores Normais TST (%)	Tempo na Cama (%)
Estágio N1	11,5	2,8	2,2
Estágio N2	263,0	64,9	50,0
Estágio N3	30,0	7,4	5,7
REM	100,5	24,8	19,1
Acordado	120,5	---	22,9

Eficiência do Sono:

Total de Mudanças de Estágio: 77
Mudanças de estágio por hora de sono: 11,4

77,1% (100 x TST/TIB)

Paciente: LUIZ GUSTAVO SANT ANNA DA CRUZ
Data do Exame: 17-01-2018

Nome: LUIZ GUSTAVO SANT ANNA DA CRUZ
Data de Nascimento: 21-10-1992
IMC: 37,18
Sexo: Masculino
Data do exame: 17-01-2018

Peso: 110 kg
Altura: 1,72 m
Médico: DR. GUILHERME SALOMON
DOMINICIS
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 17-01-2018, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 525,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 37,0 e 152,0 minutos. O tempo total de sono foi de 405,0, eficiência de 77,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 64,9%; estágio N3: 7,4%; sono REM: 24,8%. O índice de despertares foi de 47,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 82,4/h, sendo elas 104 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 71 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 82%, permanecendo 3,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 97 bpm e NREM de 53 - 99 bpm. O paciente roncou.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 82,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=82%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

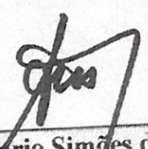
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157